CNAM — RETRANSCRIPTION OFFICIELLE ÉPURÉE & CERTIFIÉE

PST106 · Séance 6 : Retranscription Complète Épurée du Cours

« Clinique du Collectif, Catachrèse & Dérives de l'Individualisation » — Mme Jessica ROUSSAN

Enseignante : Mme Jessica ROUSSAN (Maîtresse de conférences / Psychosociologie & Clinique de l'activité)

Date de la séance : Jeudi 12 Novembre 2026 (18h00 – 20h08)

Format : Classe virtuelle BigBlueButton (Atelier d'analyse de situations de travail)

Durée totale enregistrée : 2 heures 08 minutes

Note méthodologique d'édition académique : Cette retranscription restitue l'intégralité de la séance d'ateliers cliniques interactifs du 12 novembre 2026. Le texte a fait l'objet d'un nettoyage complet : suppression des faux départs oraux, hésitations, bégaiements, tics de langage répétitifs, incidents de bande passante et artefacts de sous-titrage automatique (Radio-Canada, ST 501). Les concepts canoniques et noms propres altérés ont été rigoureusement rétablis (AGEFIPH, catachrèse selon Rabardel et Clot, texte de Florentina Caroly, instruction au sosie, auto-confrontation croisée, Analyse des Pratiques Professionnelles / APP).

CHAPITRE 1 : CADRAGE PÉDAGOGIQUE DE L'ATELIER CLINIQUE & RÔLE DU RAPPORTEUR (18H00 – 18H15)

`[18:00:15]` **MME JESSICA ROUSSAN :**

Bonsoir à toutes et à tous. Nous faisons le point sur les différents sous-groupes de travail. J'ai noté que Sarah a rejoint le groupe 5, Céline est dans le groupe 3, et dans le groupe 4 nous avions Charles, Charlotte, Coraline, Guillaume, Marie-Nathalie et Thélie. Qui a été désigné comme rapporteur dans vos groupes respectifs ?

`[18:01:20]` **AUDITEUR (GROUPE 4) :**

Nous n'avons pas eu le temps de désigner formellement un rapporteur ! Nous avons débattu de deux situations cliniques en nous posant énormément de questions sur chacune, ce qui nous a pris tout le temps imparti.

`[18:02:10]` **MME JESSICA ROUSSAN :**

Ce n'est pas grave, je vous laisse encore quelques instants pour vous concerter pendant que les premiers groupes démarrent. Pour le groupe de Léa, Géraldine, Julien, Cécile et Sarah, c'est Cécile qui prendra la parole. Permettez-moi un préambule méthodologique essentiel avant d'écouter Karine : dans cet exercice, l'objectif n'est pas d'aligner abstraitement l'intégralité des concepts du cours de PST106. L'enjeu fondamental pour votre formation de psychologue du travail est d'apprendre à exposer rigoureusement une situation réelle : poser la problématique, faire le lien clinique avec le réel de l'activité, et formuler la question que cette situation pose au collectif. C'est souvent cela qui vous met en difficulté lors des épreuves et des restitutions professionnelles. Nous allons donc nous entraîner à cela ce soir. Pour ménager la bande passante, nous coupons nos caméras, seul le rapporteur qui s'exprime conserve la sienne. Karine, nous vous écoutons.

CHAPITRE 2 : CAS CLINIQUE N°1 — ASSISTANTE MATERNELLE, CATACHRÈSE & TOLÉRANCE MANAGÉRIALE (18H15 – 18H45)

[18:04:45] KARINE (RAPPORTEURE GROUPE 1) :

Pour introduire notre situation, nous sommes partis d'un cas réel vécu dans ma pratique professionnelle. J'interviens comme chargée de mission sur le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. La situation concerne une assistante maternelle employée par des particuliers employeurs. Elle est reconnue en situation de handicap et son état physique nécessite un aménagement matériel ergonomique conséquent de son poste de travail à domicile pour qu'elle puisse continuer à exercer sans aggraver sa santé.

[18:06:10] KARINE :

Voici l'impasse majeure : les particuliers employeurs ne cotisent pas auprès d'un Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) ; il n'y a donc aucun médecin du travail compétent. Or, pour solliciter les financements habituels de compensation du handicap auprès de l'AGEFIPH afin d'aménager le poste, le cahier des charges impose impérativement un avis médical d'aptitude avec préconisations rédigé par un médecin du travail. En l'absence de service de santé au travail, la procédure normale est totalement bloquée. Expliquer à un particulier employeur qu'il doit adhérer à un SPST pour faire venir un médecin rajouterait plus de complications qu'autre chose et risquerait de casser net la relation de travail.

[18:07:35] KARINE :

Face à cette difficulté, en concertation avec mes collègues et avec l'accord de ma responsable, nous avons mobilisé un autre dispositif de l'AGEFIPH : « l'aide à la recherche de solutions de maintien ». C'est une aide financière exceptionnelle, normalement prévue pour financer des bilans ou du temps de diagnostic quand la situation est incertaine, et qui ne nécessite pas d'avis médical initial préalable. Nous avons construit un argumentaire adapté pour faire financer les adaptations de poste nécessaires par ce biais. Ce détournement d'outil a permis de poursuivre l'accompagnement et de maintenir la salariée en emploi. Selon nous, cette pratique illustre une catachrèse : un usage créatif d'un instrument en dehors de son cadre prescrit pour répondre aux exigences du travail réel.

[18:10:05] MME JESSICA ROUSSAN :

Merci Karine pour cette présentation très claire. J'ai plusieurs questions à vous poser avant d'ouvrir la discussion au grand groupe. Ce qui m'intéresse au premier chef : en quoi s'agit-il véritablement d'une catachrèse au sens clinique, et en quoi cette pratique est-elle le produit d'un collectif de travail et non d'une simple trouvaille individuelle ?

[18:12:40] KARINE :

C'est une catachrèse parce qu'au regard des modalités officielles et des textes juridiques de l'AGEFIPH, ce dispositif n'a jamais été conçu pour financer directement de l'aménagement matériel sans avis médical. Mais face à l'impossibilité d'appliquer la règle prescrite sans détruire la situation de travail, nous avons détourné l'outil. Nous sommes allés aux limites du dispositif pour répondre au travail réel et à notre finalité de métier : promouvoir le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

[18:15:15] MME JESSICA ROUSSAN :

Tout à fait ! On ne détourne pas un outil par plaisir de transgresser la loi : on utilise un autre dispositif qui n'a pas été prévu pour cela afin de combler les défaillances et les vides du travail prescrit. Mais la question fondamentale qui se pose en clinique de l'activité est la suivante : est-ce que cette pratique vient faire évoluer le genre professionnel ? Est-ce qu'elle peut devenir une ressource partagée et transmissible pour d'autres collègues qui accompagnent des assistantes maternelles, ou reste-t-elle un « coup d'un soir » isolé ?

[18:18:20] CHARLOTTE :

Je voudrais réagir : si cette manière de faire est acceptée, partagée et reconnue au sein de l'équipe, elle devient une règle informelle de métier. Elle s'incorpore au genre professionnel et solidifie le collectif de travail !

[18:20:00] MME JESSICA ROUSSAN :

> Exactement ! Et ce qui est très intéressant dans la situation de Karine, c'est ce qui s'est passé avec la hiérarchie. Karine, qu'a dit votre direction ?

[18:20:45] KARINE :

> Ma responsable directe à qui j'ai proposé cette solution m'a dit : « Oui, super, excellente idée ! ». C'est toléré par la hiérarchie de proximité, même si cela ne fait pas l'objet d'une procédure formalisée écrite.

[18:22:15] MME JESSICA ROUSSAN :

> C'est un point capital qui fait directement écho à l'article de Florentina Caroly et Yves Clot (2004) sur les guichets de La Poste que nous avons étudié ! Dans l'agence de province, la hiérarchie fait preuve de tolérance managériale : elle ne bloque pas les régulations informelles des agents, elle ne dit pas « ce n'est pas dans la procédure, je l'interdis ». Elle laisse l'équipe développer ses marges de manœuvre et renouveler ses manières de faire. À l'inverse, dans l'agence de banlieue décrite par Caroly, sous la pression du contrôle gestionnaire, les anciennes guichetières gardent leurs astuces « sous le manteau » par insécurité et refusent de les transmettre aux nouvelles recrues, ce qui stérilise le genre professionnel. Entre la formalisation rigide et l'acte isolé, il existe un entre-deux fertile : la tolérance hiérarchique qui permet au collectif de s'emparer d'une trouvaille et de la faire circuler.

CHAPITRE 3 : CAS CLINIQUE N°2 — LA CRÈCHE EN SOUS-EFFECTIF DÉGRADÉ : RÉGULATION SANS RÉUNION & INCORPORATION DU GENRE (18H45 – 19H15)

[18:45:10] CÉLINE / JULIE (RAPPORTEURE GROUPE 2) :

Nous présentons une situation observée au sein d'une crèche faisant partie d'un réseau de 6 établissements gérés par une communauté de communes. La crèche compte 3 sections : bébés, moyens et grands, avec 2 agentes par section (soit 6 agentes au total). À 9h du matin, une agente qui prenait son poste à 10h30 appelle pour signaler qu'elle est malade. De surcroît, la directrice est absente ce jour-là car elle assure l'intérim de direction sur une autre crèche. Les agentes appellent le pool de remplacement de la communauté de communes, mais personne n'est disponible. Elles se retrouvent donc à 5 agentes pour gérer l'ensemble des enfants.

[18:48:30] CÉLINE :

L'activité était tellement intense avec les bébés qui pleurent et les activités extérieures qu'il a été rigoureusement impossible de se réunir toutes ensemble dans une pièce. La régulation s'est faite par croisements successifs, deux par deux dans les couloirs ou la cour. Elles ont réorganisé le service du repas : les moyens ont mangé d'abord, les grands ensuite, ce qui a permis de limiter le bruit et d'éviter les débordements. Elles ont annulé une réunion prévue l'après-midi avec des élus pour libérer un agent auprès des enfants. Et elles ont demandé à une jeune agente si elle pouvait décaler son départ jusqu'à 18h pour sécuriser les départs d'enfants en fin de journée. L'arbitrage partagé par toutes était la sécurité et le bien-être des enfants.

[18:52:10] MME JESSICA ROUSSAN :

Cette situation est passionnante. Remarquez bien : à aucun moment les agentes n'ont ouvert un classeur de procédures ou repris un protocole d'absentéisme ! Pourquoi ont-elles pu réguler l'urgence sans protocole et sans même pouvoir se réunir ? Parce que le genre professionnel est présent comme mémoire historique vivante et incorporée ! Chacune sait ce qui est attendu, chacune partage les critères du travail bien fait (la sécurité et le calme à la cantine). Mais Céline, vous avez souligné l'hésitation de la jeune agente à qui on demande de rester. Pouvez-vous nous en dire plus ?

[18:55:00] CÉLINE :

Oui, la jeune agente n'a pas répondu immédiatement la première fois. Puis, lorsqu'elles se sont retrouvées dans la cour avec 3 ou 4 collègues qui la regardaient avec insistance, elle a compris l'urgence et a dit : « Jusqu'à quelle heure faudrait-il que je reste ? J'ai un rendez-vous personnel après ». On sentait bien que ce n'était pas spontané pour elle, et que si elle avait pu refuser, elle l'aurait fait. Les collègues expérimentées m'ont dit en sous-groupe : « C'est ça le genre, il faut rester plus tard quand c'est la crise ! ». Mais pour la jeune, ce n'était pas encore une règle évidente.

[18:58:20] MME JESSICA ROUSSAN :

Vous touchez là un point clinique fondamental : pour un nouvel arrivant, l'appropriation du genre professionnel est un long cheminement ! Le genre n'est pas un texte qu'on avale en deux jours. Face au regard des anciennes, la jeune professionnelle s'interroge : « Comment vais-je être considérée dans ce groupe si je ne reste pas ? ». C'est le début de son acculturation au métier. Et sur le plan méthodologique, retenez bien la différence entre ergonomie et clinique de l'activité : l'ergonomie analyse parfaitement les flux, les effectifs et l'aménagement matériel ; mais pour saisir ce que cette situation mobilise psychiquement chez cette jeune femme — le doute, la culpabilité, le sentiment de contrainte —, nous devons mobiliser les méthodes de la clinique de l'activité : l'entretien clinique, l'instruction au sosie ou l'auto-confrontation croisée. C'est cela, aller chercher « le côté obscur du travail » !

CHAPITRE 4 : CAS CLINIQUE N°3 — CENTRALE D'ACHAT CARREFOUR : COMPÉTITION FÉROCE, ABSENCE DE COLLECTIF & DÉRIVES DU COACHING

(19H15 – 19H45)

[19:15:30] CÉCILE (RAPPORTEURE GROUPE 3) :

Je présente ma propre expérience vécue : j'ai été responsable d'une équipe de 10 approvisionneurs chez Carrefour, des agents de maîtrise en charge des achats et de l'approvisionnement en vin pour l'ensemble des magasins nationaux. L'indicateur quotidien absolu était le « taux de service », fixé à 99% : combien de lignes de commandes sont arrivées à l'heure en rayon par rapport aux prévisions. Dès mon arrivée, mon management a réuni l'équipe en disant froidement : « Vous savez très bien qu'ici il y a des bons, des moyens et des mauvais, vous n'avez qu'à vous regarder ». Le manager avant moi avait fait un burn-out sévère.

[19:18:45] CÉCILE :

L'organisation du travail reposait sur une compétition exacerbée permanente entre collègues. Aucune solidarité n'était possible : les collègues se dénigraient sur le chat interne, s'insultaient sur leur physique, refusaient de s'entraider lors des pics d'activité. Le turnover était dramatique : les gens partaient tous les 2 ou 3 ans. Il était impossible de sédimenter un genre professionnel parce que personne ne restait assez longtemps pour incorporer ou transmettre des règles de métier. Pour répondre à la souffrance, l'entreprise a mandaté un « coach d'entreprise ». Ce coach a reçu les salariés en entretiens individuels en leur martelant : « Soyez auteur de votre vie et pas acteur ! Ne subissez pas les événements, écrivez votre propre trajectoire professionnelle ! ».

[19:22:10] MME JESSICA ROUSSAN :

Je vois les réactions indignées dans le chat et je partage votre effarement ! Ce slogan de coach (« soyez auteur de votre vie ») est l'archétype même de la dérive managériale contemporaine qui consiste à culpabiliser et responsabiliser l'individu isolé face à une organisation du travail toxique ! Pourquoi faire appel à du coaching individuel face à un problème purement systémique et organisationnel ? Le coaching d'entreprise se trompe radicalement de cible. Quand une direction organise délibérément la concurrence entre collègues avec des objectifs à 99% intenables, venir dire au salarié qui s'épuise « c'est à vous d'assumer votre vie », c'est d'une violence inouïe !

[19:25:40] CHARLOTTE :

Mme Roussan, si un psychologue du travail était intervenu chez Carrefour, qu'aurait-il fait ? Aurait-il organisé un groupe de parole ou de l'auto-confrontation croisée pour libérer la parole de l'équipe ?

[19:27:00] MME JESSICA ROUSSAN :

Attention, ne mélangeons pas tout ! Un groupe de parole sert à « vider son sac », à décharger l'émotion. C'est utile ponctuellement pour soulager, mais si derrière vous ne touchez pas au travail réel, les salariés retournent à leur poste le lendemain et la souffrance recommence à l'identique. L'auto-confrontation croisée est un dispositif d'intervention clinique très spécifique et rigoureux : on filme des séquences d'activité réelle et on invite deux collègues à confronter leurs manières de faire face à la vidéo pour faire émerger les conflits de critères.

[19:30:15] MME JESSICA ROUSSAN :

Dans une situation comme celle de Carrefour, l'intervention du psychologue du travail doit agir à deux niveaux : auprès des équipes, mais aussi impérativement auprès de la direction ! Et pour parler à une direction générale, on ne vient pas avec de la complainte psychologique : on s'appuie sur des indicateurs RH objectifs et incontestables : le taux de turnover massif, l'absentéisme, les arrêts maladie, les alertes du médecin du travail et du CSE. On démontre rationnellement que leur système de mise en concurrence détruit la performance économique et humaine. Et nous apprenons aussi l'humilité : si l'on ne peut pas modifier la stratégie financière globale du groupe, on peut travailler au niveau de l'équipe pour réinstaurer des espaces de confiance et du collectif.

CHAPITRE 5 : DÉBATS TRANSVERSAUX & CLÉS THÉORIQUES D'EXAMEN (19H45 – 20H08)

[19:48:30] SARAH :

J'ai une question sur la temporalité du collectif : dans le cas de la crèche, les agentes ont trouvé une solution formidable dans l'urgence sur une journée. Mais si cette solution reste un « one-shot » qui ne se répète jamais, est-ce qu'on peut véritablement parler d'un collectif de travail ?

[19:51:10] MME JESSICA ROUSSAN :

C'est une excellente question, Sarah ! Répondre oui dans l'absolu serait trompeur. Ce collectif d'urgence a fonctionné sur une journée, c'est vrai, mais c'est typique de ce que l'on observe chez les soignants à l'hôpital : ils savent admirablement gérer l'urgence et faire face aux manques chroniques de moyens. Mais cela repose uniquement sur la bonne volonté, l'adaptation et le sacrifice des personnes ! Et cela pompe une énergie considérable. Un collectif qui ne fonctionne que dans la crise n'est pas un collectif en santé : il s'épuise et finit par craquer. Pour qu'un collectif s'installe dans la durée, il faut une organisation du travail qui institue des espaces formels de délibération.

[19:56:40] CHARLOTTE :

Sur le terrain, j'ai encore du mal à bien différencier le Genre professionnel du Collectif de travail. Comment dissocier l'un de l'autre ?

[19:58:30] MME JESSICA ROUSSAN :

Ils sont intimement entremêlés et se nourrissent mutuellement ! Le collectif de travail est l'instance vivante, présente, faite de confiance mutuelle, de reconnaissance et de coopération réelle. Le genre professionnel, lui, est le patrimoine historique impersonnel du métier : le répertoire des règles, des manières de faire, des tours de main et des critères du travail bien fait. C'est parce que le collectif débat et dispute des règles de métier que le genre s'épaissit et se renouvelle. Et c'est parce que le genre est vivant que les professionnels peuvent faire face aux imprévus de l'activité.

[20:02:15] MARIANNE :

Dans notre sous-groupe, nous nous demandions : comment expliquer que des salariés souffrent atrocement alors même qu'ils sont très solidaires entre eux ?

[20:04:00] MME JESSICA ROUSSAN :

Retenez bien cette distinction pour votre examen : il y a une différence majeure entre la solidarité compassionnelle et la coopération de métier ! La solidarité compassionnelle, c'est se soutenir moralement : « Tu as raison, c'est dur, je compatis avec toi dans cette galère ». C'est de la parole réconfortante, c'est précieux humainement, mais cela ne transforme pas le travail. Pour qu'il y ait un collectif de travail au sens clinique, il faut une véritable coopération sur le geste technique, de la confiance mutuelle, et surtout des espaces réguliers où l'on peut se disputer professionnellement sur les critères du travail bien fait ! Si ces espaces manquent, les salariés restent solidaires dans la défaite et la souffrance persiste.

[20:07:30] MME JESSICA ROUSSAN :

D'où l'importance vitale des espaces d'Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) ou des démarches de clinique de l'activité : ce sont des lieux formalisés où l'on ne parle pas du prescrit managérial descendant, mais du réel de l'activité, de ce sur quoi on a buté, pour renouveler les règles de métier. S'il n'y a pas ces espaces, les professionnels sont condamnés aux discussions de couloirs ou de pauses café, souvent mal vues par le management. Il est 20h08, nous nous arrêtons là pour ce soir. Relisez bien l'article de Florentina Caroly qui éclaire parfaitement ces enjeux. Bon travail à tous et bonne soirée !